

"La paciente de 94 años, diagnosticada con síndrome de fragilidad geriátrica y sarcopenia, presenta un cuadro clínico complejo caracterizado por un elevado nivel de dolor (8/10) y una grave dependencia (Índice de Barthel de 20). En el momento de la evaluación, la paciente se encuentra sentada en la cama, con una actitud postural caracterizada por una notable flexión de la columna vertebral y una leve inclinación hacia adelante, lo que sugiere una limitación en la flexibilidad articular y una posible kinesiofobia. La marcha es laboriosa y requiere de apoyo para mantener el equilibrio, lo que indica una disminución notable en el balance articular.\n\nEl dolor crónico produce una reducción significativa en la movilidad activa y pasiva, siendo difícil para la paciente realizar movimientos de flexión, extensión y rotación en las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo. La presencia de múltiples fármacos (polifarmacia) y la debilidad muscular provocada por la sarcopenia agudizan la situación, lo que hace que la paciente experimente un aumento en la fatiga y el aislamiento.\n\nLa paciente también presenta barreras psicosociales importantes, como un notable miedo al movimiento y a la posibilidad de perder el equilibrio, lo que la lleva a restringir sus actividades y a evitar cualquier tipo de esfuerzo físico. Esto, a su vez, contribuye a su aislamiento y a su sentimiento de impotencia.\n\nEn cuanto a la asistencia requerida para actividades básicas, la paciente necesita apoyo para realizar actividades como el aseo, vestirse y realizar transferencias entre la cama y la silla, lo que sugiere una gran dependencia en los cuidados de atención personal y en la movilización. La implementación de estrategias de fisioterapia específicas, como el trabajo en ROM y la educación en la prevención de caídas, es crucial para mejorar la movilidad y la autonomía de la paciente, así como para reducir su dolor y mejorar su calidad de vida."